UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

CHIRURGIE VASCULAIRE
Suspicion de TVP
Sans patient
Avec geste clinique

Nom du rédacteur : MAMELI Eléonore **Date de rédaction : 23/11/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N°071 – Douleur d'un membre

Domaine de compétence n°1: Examen clinique

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

https://livret.uness.fr/lisa/Douleur_d%27un_membre_(supérieur_ou_inférieur)_SDD-071

1- Organiser son raisonnement et hiérarchiser les hypothèses diagnostiques
2- Expliquer au patient les hypothèses étiologiques et les explorations nécessaires
3- Prescrire de manière raisonnée les explorations complémentaires
4- Échanger avec les différents intervenants pour la réalisation des explorations diagnostiques et thérapeutiques
5- Évaluer le mode évolutif, les facteurs déclenchants l'intensité, les caractéristiques et le retentissement fonctionnel de la douleur
6- Évaluer le retentissement socio-professionnel
7- Chercher les signes d'interrogatoire pour orienter l'enquête étiologique
8- Réaliser l'examen clinique neurologique, rhumatologique, vasculaire et cutané
9- Identifier les signes d'alerte (drapeaux rouges) orientant vers une pathologie sous-jacente nécessitant une prise ne charge urgente
10- Identifier les éléments permettant de différencier une douleur d'un membre d'origine neurologique, vasculaire, cutanée, ostéoarticulaire ou musculo-tendineuse

11- Confronter les résultats de examens complémentaires prescrits à la plainte fonctionnelle et aux données de l'examen clinique

12- Proposer une stratégie thérapeutique adaptée à l'étiologie retenue de la douleur de membre

13- Identifier les situations pouvant justifier un avis spécialisé

14- Prescrire la rééducation et l'activité physique adaptée

15- Proposer une infiltration cortisonée rachidienne, intra et péri-articulaire, si indiquée

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin OUI
- Brancard OUI : mannequin sur le brancard

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences et vous recevez Mr André NALINE, 58 ans, pour une douleur au mollet gauche évoluant depuis 2 jours.

Mr NALINE n'a pas été opéré récemment, n'a pas voyagé et ne présente pas d'antécédents de cancer.

Constantes :

- Température : 38,5°C
- Poids : 1m85 pour 95kg (IMC 27,8 kg/m2)
- TA : 120/60
- FC : 85/min
- SAT : 97% en air ambiant.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Réaliser l'examen physique
2. Enoncer le/les examen(s) diagnostique(s).

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

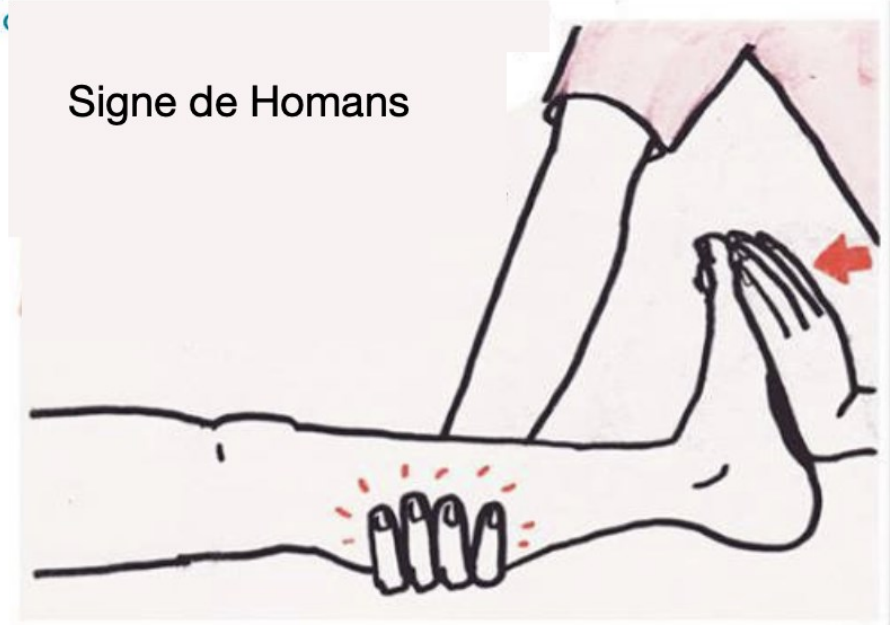
TUT'ECOS

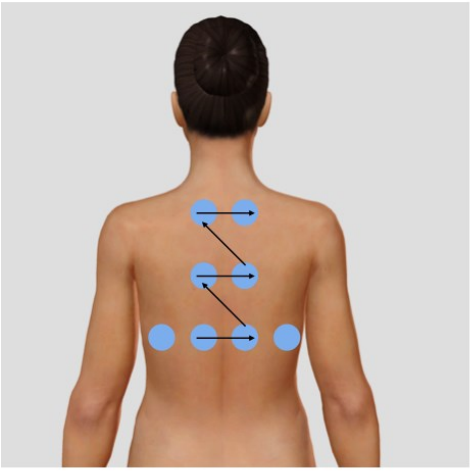
Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

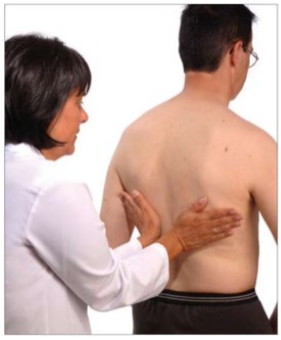
	Cocher si fait
Tache 1	
Demande son consentement au patient avant de l'examiner	
Inspection : aspect général du mollet (couleur…)	
Inspection : recherche une différence de taille entre les 2 mollets	
Inspection : recherche une dilatation des veines superficielles non variqueuses	
Examen cardiaque ET pulmonaire	
Recherche une douleur à la palpation du mollet	
Recherche une perte du ballant du mollet	
Recherche un signe de Homans	
Recherche un œdème du membre inférieur gauche ET s'il prend le godet	
Recherche une sensibilité le long du trajet veineux profond	
Tache 2	
Énonce : échodoppler veineux des membres inférieurs	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à structurer l'examen clinique	1 à 5
Aptitude à mener l'examen clinique	

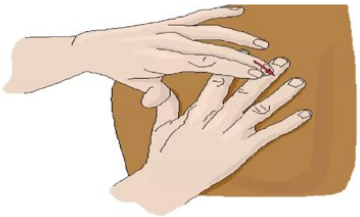
- Pas de différence de couleur
- ≠ de taille avec MI controlatéral: > 3 cm
- Douleur à la palpation: OUI
- Signe de Homans: POSITIF
- Œdème unilatéral MI: OUI
- Prise du godet: OUI
- Dilatation des veines superficielles: NON
- Douleur trajet veineux profond: OUI
- ↘ ballonnement mollet: OUI
- Auscultation cardio-pulmonaire : normale.

TUT'ECOS

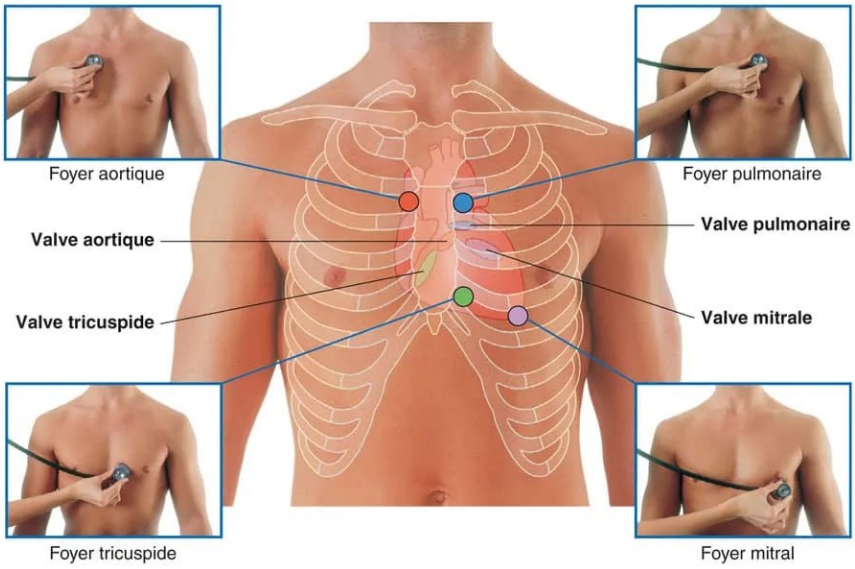








Auscultation pulmonaire :
=> de bas en haut



Score de Wells TVP	
Score de Wells simplifié en cas de suspicion de thrombose veineuse des membres inférieurs	
Items	**Score**
Antécédent personnel de TVP documentée	+1
Paralysie, parésie, immobilisation plâtrée récente d'un membre inférieur	+1
Alitement récent > 3 jours ou chirurgie < 3 mois	+1
Cancer actif	+1
Douleur/sensibilité le long d'un trajet veineux profond	+1
Augmentation de volume de tout le membre inferieur	+1
Augmentation de circonférence du mollet > 3 cm comparativement au mollet controlatéral mesurée 10 cm au-dessous de la tubérosité tibiale	+1
Œdème unilatéral prenant le godet	+1
Collatéralité veineuse non variqueuse	+1
Diagnostic alternatif au moins aussi probable	- 2
Score total **Score < 2 : TVP peu probable (score faible)** **Score ≥ 2 : TVP probable (score fort)**	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Demande son consentement au patient avant de l'examiner	1
Inspection : aspect général du mollet (couleur…)	1
Inspection : recherche une différence de taille entre les 2 mollets	1
Inspection : recherche une dilatation des veines superficielles non variqueuses	1
Examine : examen cardiaque ET pulmonaire	1
Recherche une douleur à la palpation du mollet	1
Recherche une perte du ballant du mollet	1
Recherche un signe de Homans	1
Recherche un œdème du membre inférieur gauche ET s'il prend le godet	1
Recherche une sensibilité le long du trajet veineux profond	1
Tache 2	
Énonce : échodoppler veineux des membres inférieurs	2
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à structurer l'examen clinique	Echelle de 1 à 5
Aptitude à mener l'examen clinique	

Performance insuffisante 1 point	Performance limite 2 points	Performance satisfaisante 3 points	Performance très satisfaisante 4 points	Performance remarquable 5 points
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

Performance insuffisante 1 point	Performance limite 2 points	Performance satisfaisante 3 points	Performance très satisfaisante 4 points	Performance remarquable 5 points
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

TUT'ECOS